

Verifikasi Klaim

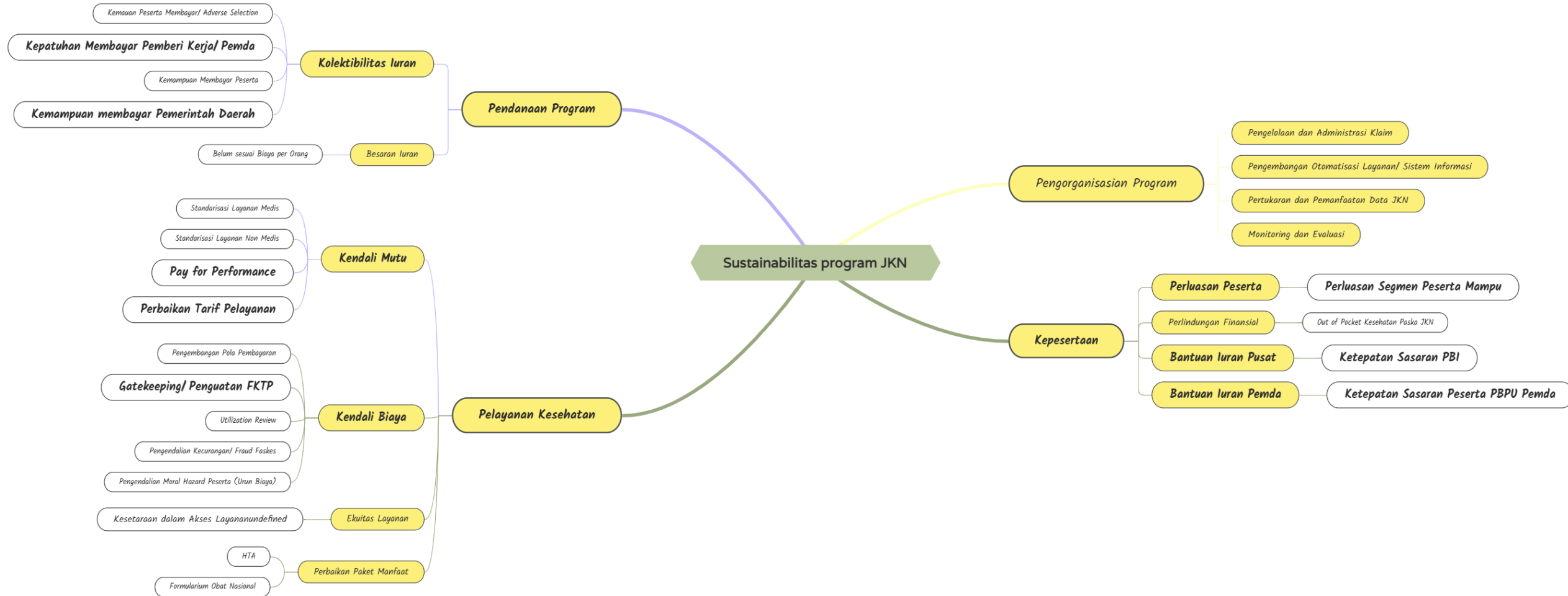
17 – 20 Juni 2026

Pusat Pembiayaan Kesehatan

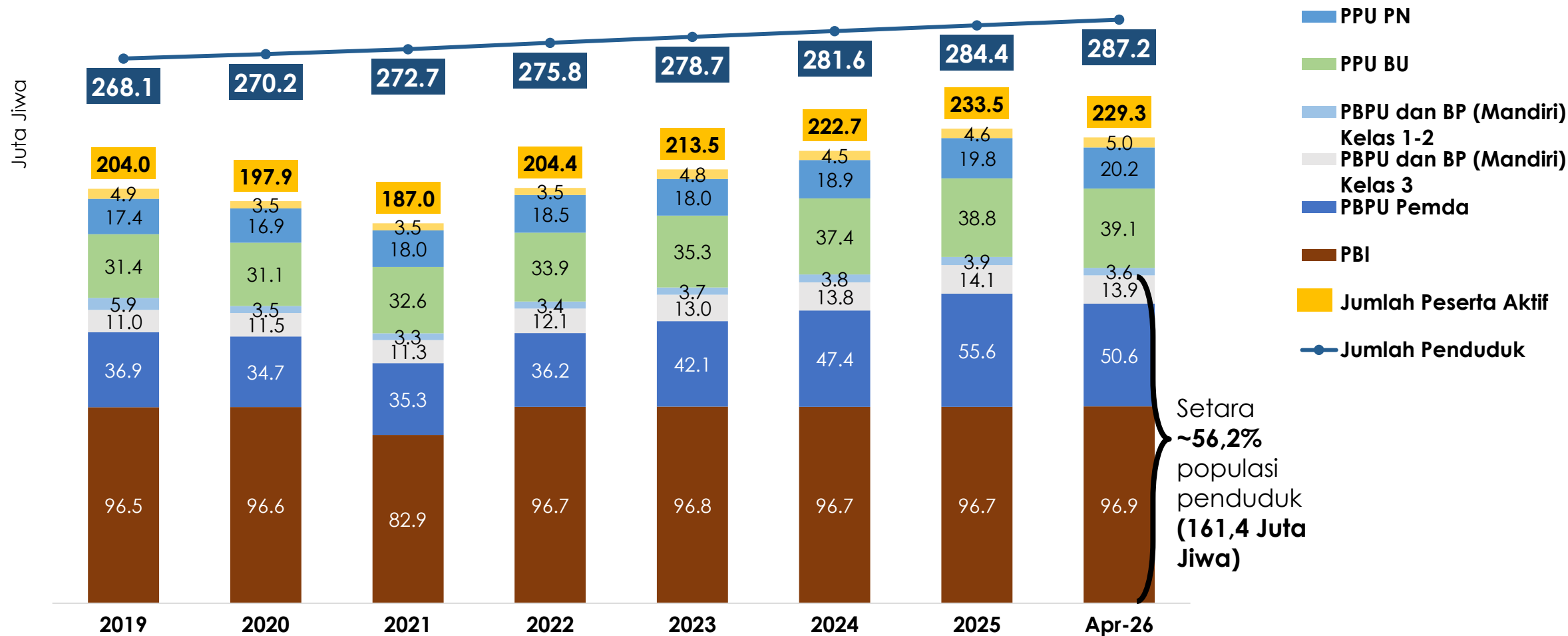


Isu dan Tantangan Program JKN

Berbagai Aspek penyelenggaraan Program saling Berinteraksi dan Menghasilkan Kesenambungan Program



Kepesertaan JKN didominasi oleh penerima skema bantuan iuran JKN (PBI, PPU Pemda dan PPU Kelas 3*) mencakup 161,4 juta jiwa



- BP PN : Bukan Pekerja Penyelenggara Negara
- PPU PN : Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara
- PPU BU: Pekerja Penerima Upah Badan Usaha

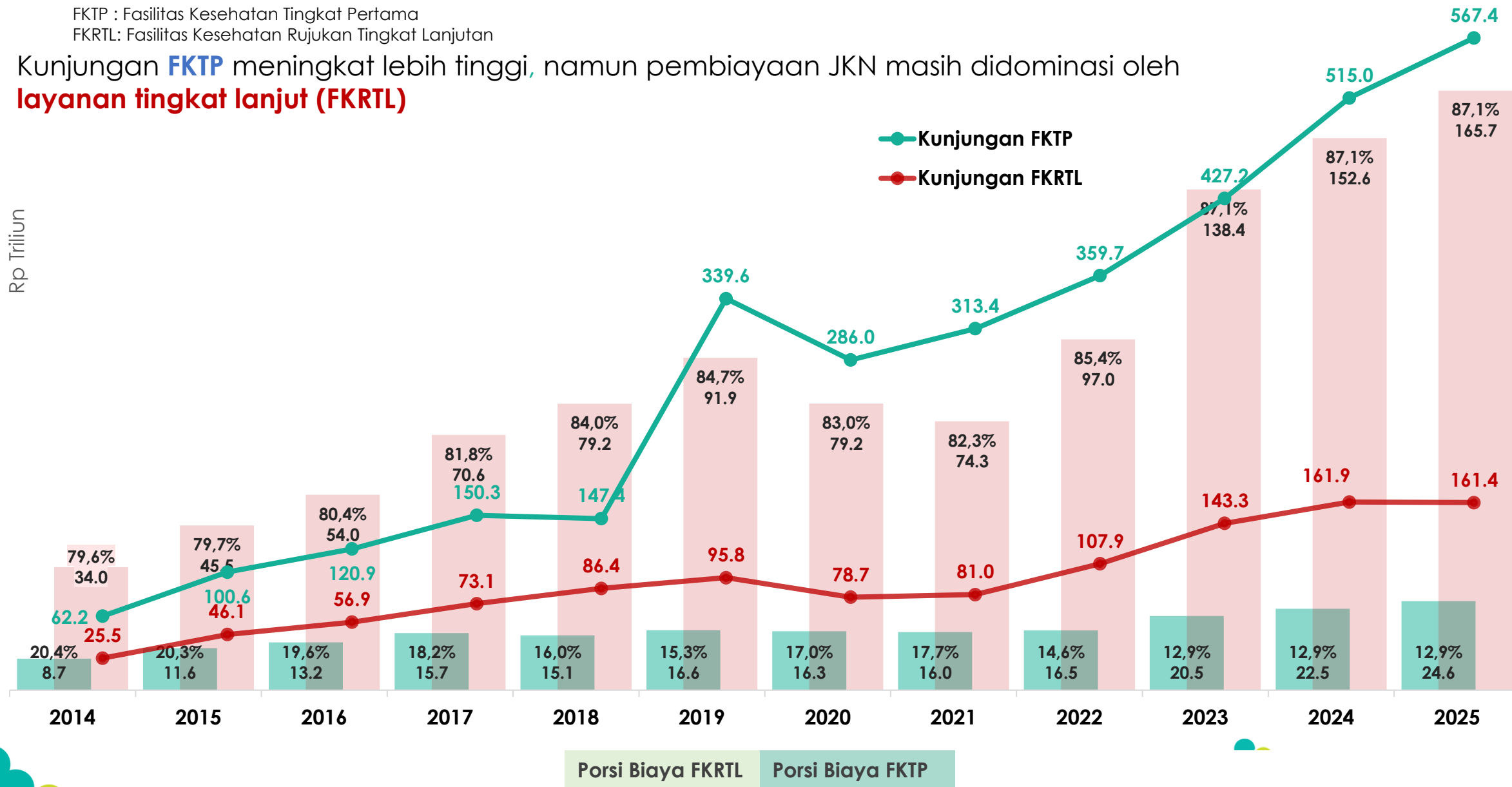
- PBU : Pekerja Bukan Penerima Upah
- PBU Pemda : Penerima Bantuan Iuran APBD
- PBI : Penerima Bantuan Iuran APBN

Hingga 2025, Tren pemanfaatan layanan JKN terus meningkat

FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

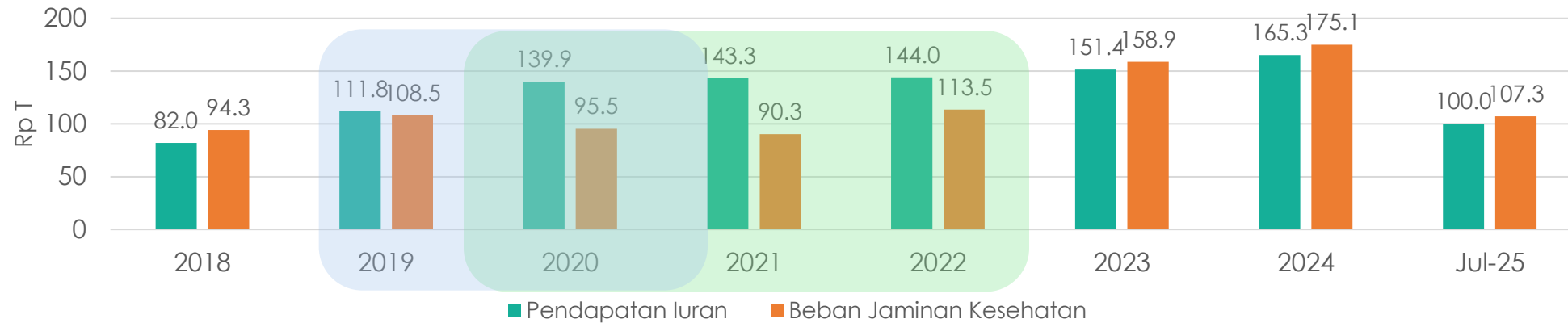
FKRTL: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Kunjungan **FKTP** meningkat lebih tinggi, namun pembiayaan JKN masih didominasi oleh **layanan tingkat lanjut (FKRTL)**

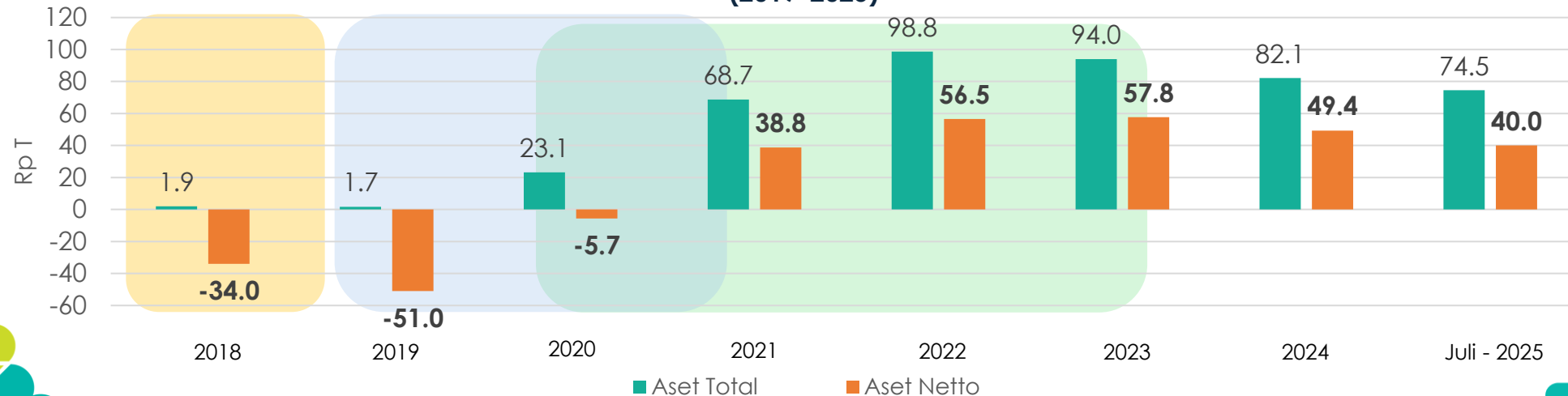


Kesehatan Keuangan Program JKN Menunjukkan Trend Negatif Pasca Pandemi Covid-19

Tren Pendapatan Iuran dibanding Beban Jaminan Kesehatan (2019–2025)



Tren Aset Netto dan Aset Total DJS Kesehatan (2019–2025)



Sumber Data : LPP BPJS Kesehatan diolah

Demand vs Mutu Layanan



Urgency Pengelolaan Klaim

Pelaksanaan **akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan** klaim layanan Kesehatan sesuai UU 40 tahun 2004, UU 24 Tahun 2011, dan Perpres 82 Tahun 2018.

Amanat Perpres 59 Tahun 2024 pasal 46 mengenai **Manfaat Medis berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan yang** meliputi: Upaya pelayanan Kesehatan perorangan, sesuai indikasi medis, pelayanan terstandar, pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, dan/atau bukan *negative list*

Amanat PMK 16 Tahun 2019 dan Tindak lanjut rekomendasi KPK Bersama TIM PK JKN untuk meningkatkan pencegahan *fraud* → Penguatan pada área **Pengajuan dan Verifikasi klaim.**

Pengelolaan Klaim secara Transparan dan Akuntabel sesuai ketentuan

Manajemen Penjaminan Manfaat



Setiap orang
bisa sakit

Pastikan



Pelayanan:

Semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan di Faskes

Penjaminan:

Hanya **Peserta eligible** dan memenuhi **Prinsip Penjaminan**

Pembayaran:

Hanya yang memenuhi **Prinsip Dasar Pembayaran Penjaminan Manfaat** dapat dibayarkan

Prinsip Dasar Pembayaran Penjaminan Manfaat:

1. Pelayanan Perorangan
2. Indikasi Medis
3. Sesuai Standard
4. Efektif
5. Efisien
6. Bukan Negative List

Pahami



Prinsip Penjaminan Manfaat:

2 Sesuai:

- Sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan
- Sesuai **Prinsip Dasar Pembayaran Penjaminan Manfaat**

3 Layak:

- Layak Indikasi Rawat Jalan; Rawat Inap; IGD
- Layak Kelengkapan isi berkas
- Layak koding ICD 10 dan ICD 9

1 Tanpa:

Tanpa Potensi Fraud

Manajemen Klaim JKN Secara Transparan dan Akuntabel

1. Mengacu Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 76 dan isi kontrak (PKS) mengenai kewajiban FKRTL mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap
2. Implementasi Permenkes 26 Tahun 2021 mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Dokter, Koder, dan Verifikator BPJS Kesehatan
3. Implementasi Permenkes 16 Tahun 2019 Pasal 3 dimana BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
4. FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan (fraud)



RUMAH SAKIT

- ✓ Pelayanan Medis (Spesialis/Subspesialis)
- ✓ Pelayanan penunjang
- ✓ Prosedur/Tindakan
- ✓ sesuai dengan Standar (PNPK, PPK, Clinical Pathway)

Dokter
✓ Melengkapi Rekam Medis
✓ Membuat Resume Medis dengan lengkap, jelas, spesifik

Koder
✓ Menterjemahkan resume medis menjadi koding diagnosis dan prosedur

Surat Pernyataan Pemeriksaan Klaim oleh Tim Pencegahan Kecurangan Faskes dan Surat dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Oleh Direktur



BPJS KESEHATAN

MEKANISME AKUNTABILITAS & MEKANISME CHECK AND BALANCE

- Verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta Tindakan yang ditulis oleh dokter di Resume Medis dengan ICD-10 dan ICD 9 CM ver Th 2010



TRUST

+

FAIRNESS



Bukan untuk mengurangi manfaat tetapi untuk memastikan kesesuaian Penjaminan

Alur Proses Klaim JKN di Faskes dan BPJS Kesehatan

Mendorong pengaturan **klaim pending-dispute** dalam Peraturan BPJS melalui harmonisasi lintas K/L guna memberikan kepastian bagi



Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL)

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Pengajuan Klaim

Verifikasi Klaim

Klaim Layak Bayar

Klaim Pending

Klaim Dispute

Klaim Tidak Layak



BPJS Kesehatan

Pembayaran Klaim

Verifikasi Pasca Klaim

Audit Administrasi Klaim

Periodik setiap bulan

Min. 2 kali pada Fasyankes yg terindikasi fraud

Klaim Pending

Sifat: Perlu konfirmasi/perbaikan (berkas tidak lengkap atau kesalahan coding).

Tindak Lanjut: Koordinasi via V-Claim dan diajukan kembali dalam **batas waktu 6 bulan**.



Klaim Dispute

Sifat: Ketidaksepakatan medis/coding/obat/manfaat antara BPJS dan Faskes

Tindak Lanjut: Penyelesaian berjenjang via Berita Acara Dispute. **Dikecualikan dari masa kadaluarsa.**



Klaim Tidak Layak

Sifat: Tidak sesuai manfaat, fraud, atau kadaluarsa.

Tindak Lanjut: Status final, klaim **tidak dibayarkan** dan proses administrasi selesai.

Pengajuan Klaim JKN yang Berkualitas

Validasi Peserta	Pemberian Layanan	Dokumentasi Pelayanan	Pengodean Klinis	Pemeriksaan & Kendali Mutu Klaim	Finalisasi Dokumen Klaim	Pengajuan Klaim ke BPJS Kesehatan
✓ Pastikan akses layanan oleh orang yang tepat melalui pemanfaatan Validasi Biometrik ✓ Sesuai ketentuan Rujukan	✓ Layanan diberikan sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kesehatan: pelayanan perorangan, indikasi medis, terstandar, efektif, efisien dan bukan <i>negative list</i>. ✓ Layanan diberikan sesuai legalitas adm sarpras dan/atau SDM kesehatan ✓ Hindari Pemecahan Layanan.	✓ Resume Medis/ Rekam medis diisi dengan lengkap sesuai dengan layanan yang diberikan ✓ DPJP menuliskan Diagnosis dan/atau tindakan lengkap, jelas dan spesifik	✓ Lakukan pengodean klinis berdasarkan resume medis yang dituliskan DPJP ✓ Koder melakukan Pengodean Klinis sesuai dengan kaidah pengodean klinis ✓ Hindari upcoding atau manipulasi	✓ Lakukan analisa Utilization Review (UR) untuk mendeteksi anomali (misal: frekuensi prosedur tidak wajar). ✓ Lakukan Verifikasi Internal (kesesuaian klaim yang akan diajukan dengan dokumen klaim). ✓ Pemeriksaan klaim oleh TIM PK JKN Faskes.	✓ Pastikan Administrasi Umum dan Khusus sudah lengkap, jelas, dan sesuai ✓ Pastikan dokumen penunjang lengkap, jelas, dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan	✓ Klaim yang diajukan merupakan klaim yang sudah sesuai dengan Prinsip Penjaminan Manfaat ✓ Pastikan Jumlah data dengan dokumen yang akan diajukan sama ✓ Pengajuan melalui Aplikasi sudah tepat



1. Perkuat Komitmen untuk:

- TAGIH → hanya untuk Pelayanan yang diberikan sesuai INDIKASI MEDIS dan tata laksana medis
 - KODING → TEPAT, CERMAT → PANTANG UPCODING (dengan tujuan menaikkan pembiayaan JKN)
 - BERINTEGRITAS → tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam pengodean (wewenang KODER), DPJP menulis data medis (termasuk diagnosis/prosedur medis) yang lengkap, jelas dan spesifik.
-

2. Pastikan pengajuan klaim nya sudah tepat prosedur pelayanan dan tepat koding



**“Sekecil apapun peranmu, akan memberi dampak besar.
Berikan kontribusi terbaik, Bersama kita jaga Program JKN”**



TATA KELOLA KLAIM



Tata Kelola Klaim meliputi strategi preventif, kuratif, dan monitoring agar klaim rumah sakit tidak banyak bermasalah (pending, dispute, atau fraud).

1. Perencanaan & Tata Kelola Internal

- Bentuk **tim kendali mutu & kendali biaya (KMKB)** di RS.
- Tetapkan **SOP klaim JKN** yang jelas (alur pasien, pencatatan, coding, verifikasi, pengajuan klaim).
- Integrasikan **rekam medis elektronik** dengan sistem klaim INA-CBG's untuk meminimalisir kesalahan input.

2. Kelengkapan & Kualitas Dokumen

- Pastikan **rekam medis terisi lengkap, jelas, dan sesuai standar**.
- Lakukan **audit internal rekam medis** sebelum klaim dikirim.
- Terapkan **checklist klaim**: diagnosa utama, kode tindakan, resume medis, hasil penunjang.





3. Manajemen Coding & Klaim

- Gunakan **koder terlatih** (ICD-10, ICD-9-CM, INA-CBG's).
- Lakukan **peer review coding** untuk kasus yang kompleks.
- Sediakan **software validasi coding** untuk mengurangi kesalahan teknis.

4. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan

- Bangun **komunikasi rutin** dengan verifikator BPJS.
- Ikuti **sosialisasi kebijakan terbaru** terkait aturan klaim.
- Siapkan **dokumen pendukung** jika ada dispute/pending (laboratorium, radiologi, informed consent, dll).

5. Monitoring & Evaluasi

- Buat **dashboard klaim**: jumlah klaim masuk, pending, dispute, waktu pembayaran.
- Lakukan **analisis tren pending/dispute** untuk mencari pola masalah.
- Susun **laporan bulanan** untuk manajemen RS.





6. Pencegahan Fraud

- Terapkan **kebijakan zero tolerance terhadap fraud**.
- Lakukan **audit internal berkala** untuk mencegah upcoding, phantom billing, atau klaim ganda.
- Edukasi tenaga medis tentang **etik dan integritas** dalam klaim.

7. Penguatan SDM

- Latih dokter dalam **penulisan diagnosis yang sesuai kaidah ICD-10**.
- Tingkatkan kapasitas koder & petugas klaim melalui pelatihan rutin.
- Libatkan **tim mutu, tim IT, dan manajemen** dalam integrasi sistem klaim.





1. Komitmen DPJP dalam membuat resume medis secara Lengkap, Jelas, dan Spesifik

2. Komitmen Koder dalam melakukan koding dengan tepat dan cermat tanpa Fraud

3. *Komitmen Bersama dalam mendukung keberhasilan program JKN dengan melakukan tata Kelola klaim dengan penuh integritas*

4. *Komitmen bersama dalam membangun system pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program JKN*



